

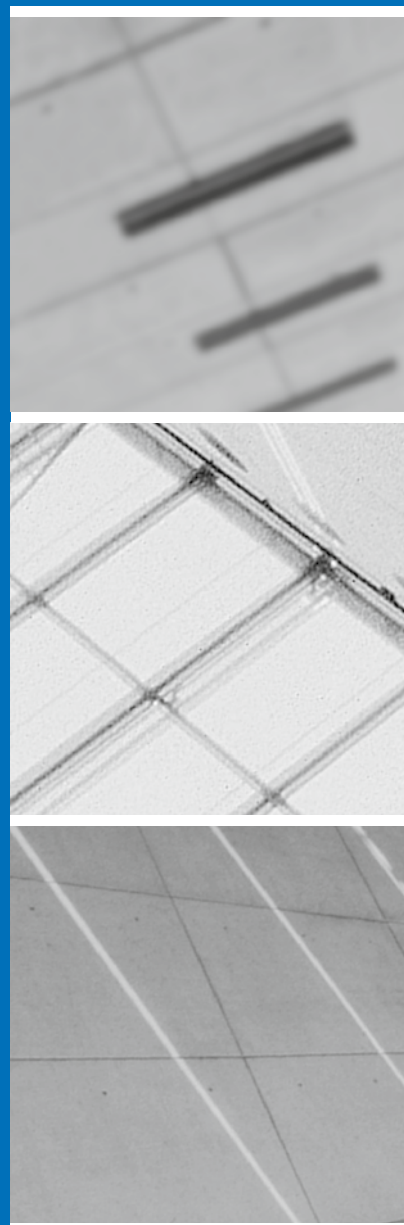
Bulletin 37/13

Bundesamt für Gesundheit



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG



Herausgeber

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern (Schweiz)
www.bag.admin.ch

Redaktion

Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern
Telefon 031 323 87 79
drucksachen-bulletin@bag.admin.ch

Druck

ea Druck + Verlag AG
Zürichstrasse 57
CH-8840 Einsiedeln
Telefon 055 418 82 82

Abonnemente, Adressänderungen

BBL, Vertrieb Bundespublikationen
CH-3003 Bern
E-Mail: verkauf.zivil@bbl.admin.ch
Telefon 031 325 50 50
Fax 031 325 50 58

ISSN 1662-7350

Übertragbare Krankheiten

Meldungen Infektionskrankheiten 632

Sentinella-Statistik 634

Invasive H. influenzae Erkrankungen 1988–2011 635

Verbraucherschutz

**Informationsschreiben Nr. 171: Empfehlung zur Beurteilung
von Perchloratrückständen in Lebensmitteln** 640

Kranken- und Unfallversicherung

Spezialitätenliste 641

Betäubungsmittel

Rezeptsperrung 646

Kommunikationskampagne

Love Life 647

Übertragbare Krankheiten

Meldungen Infektionskrankheiten

Stand am Ende der 35. Woche (03.09.2013)^a

^a Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in *kursiver* Schrift angegebenen Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100 000 Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitperioden.

^b Ausgeschlossen sind materno-foetale Röteln.

^c Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen.

^d Siehe Influenza-Überwachung im Sentinella-Meldesystem www.bag.admin.ch/sentinella.

^e Die Meldepflicht für Q-Fieber wurde auf den 1.11.2012 eingeführt.

^f Bestätigte und wahrscheinliche Fälle von klassischer CJD.

Da das diagnostische Prozedere bis zwei Monate betragen kann, wird auf eine detaillierte Darstellung nach Meldewochen verzichtet. Die Zahl der bestätigten und wahrscheinlichen Fälle betrug im Jahre 2011 10 und im Jahre 2012 9.

	Woche 35			Letzte 4 Wochen			Letzte 52 Wochen			Seit Jahresbeginn		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Respiratorische Übertragung												
Tuberkulose	15 <i>9.80</i>	7 <i>4.60</i>	27 <i>17.60</i>	39 <i>6.30</i>	35 <i>5.70</i>	53 <i>8.60</i>	514 <i>6.40</i>	524 <i>6.60</i>	554 <i>6.90</i>	378 <i>7.00</i>	350 <i>6.50</i>	406 <i>7.60</i>
Invasive Meningokokken-Erkrankungen		1 <i>0.60</i>		3 <i>0.50</i>	1 <i>0.20</i>	1 <i>0.20</i>	39 <i>0.50</i>	66 <i>0.80</i>	65 <i>0.80</i>	35 <i>0.60</i>	42 <i>0.80</i>	50 <i>0.90</i>
Legionellose	7 <i>4.60</i>	7 <i>4.60</i>	6 <i>3.90</i>	40 <i>6.50</i>	30 <i>4.90</i>	19 <i>3.10</i>	328 <i>4.10</i>	258 <i>3.20</i>	248 <i>3.10</i>	198 <i>3.70</i>	156 <i>2.90</i>	146 <i>2.70</i>
Haemophilus influenzae: invasive Erkrankungen	2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>	5 <i>0.80</i>	2 <i>0.30</i>	6 <i>1.00</i>	97 <i>1.20</i>	76 <i>1.00</i>	101 <i>1.30</i>	67 <i>1.20</i>	53 <i>1.00</i>	73 <i>1.40</i>
Masern	3 <i>2.00</i>	1 <i>0.60</i>	9 <i>5.90</i>	34 <i>5.50</i>	5 <i>0.80</i>	17 <i>2.80</i>	164 <i>2.00</i>	76 <i>1.00</i>	689 <i>8.60</i>	160 <i>3.00</i>	62 <i>1.20</i>	666 <i>12.40</i>
Röteln ^b							8 <i>0.10</i>	10 <i>0.10</i>	6 <i>0.08</i>	7 <i>0.10</i>	7 <i>0.10</i>	5 <i>0.09</i>
Röteln materno-foetal ^c												
Influenzaviren ^d	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>		3 <i>0.50</i>	2 <i>0.30</i>	1 <i>0.20</i>	2947 <i>36.90</i>	1048 <i>13.10</i>	1676 <i>21.00</i>	2892 <i>53.80</i>	1028 <i>19.10</i>	1518 <i>28.20</i>
Saisonale Typen, Subtypen												
Invasive Pneumokokken-Erkrankungen	4 <i>2.60</i>	7 <i>4.60</i>	7 <i>4.60</i>	24 <i>3.90</i>	26 <i>4.20</i>	23 <i>3.70</i>	988 <i>12.40</i>	905 <i>11.30</i>	962 <i>12.00</i>	738 <i>13.70</i>	642 <i>11.90</i>	681 <i>12.70</i>
Faeco-orale Übertragung												
Campylobacter	231 <i>150.30</i>	237 <i>154.20</i>	174 <i>113.20</i>	785 <i>127.70</i>	909 <i>147.90</i>	897 <i>145.90</i>	7518 <i>94.10</i>	8596 <i>107.60</i>	7341 <i>91.90</i>	4782 <i>88.90</i>	5831 <i>108.40</i>	5121 <i>95.20</i>
Salmonella typhi/paratyphi	3 <i>2.00</i>			4 <i>0.60</i>	4 <i>0.60</i>	2 <i>0.30</i>	31 <i>0.40</i>	25 <i>0.30</i>	31 <i>0.40</i>	19 <i>0.40</i>	15 <i>0.30</i>	17 <i>0.30</i>
Übrige Salmonellen	52 <i>33.80</i>	63 <i>41.00</i>	54 <i>35.10</i>	202 <i>32.90</i>	209 <i>34.00</i>	196 <i>31.90</i>	1275 <i>16.00</i>	1291 <i>16.20</i>	1286 <i>16.10</i>	810 <i>15.10</i>	810 <i>15.10</i>	832 <i>15.50</i>
Shigellen	2 <i>1.30</i>	7 <i>4.60</i>	7 <i>4.60</i>	23 <i>3.70</i>	23 <i>3.70</i>	16 <i>2.60</i>	178 <i>2.20</i>	143 <i>1.80</i>	203 <i>2.50</i>	102 <i>1.90</i>	88 <i>1.60</i>	109 <i>2.00</i>
Enterohämorrhagische E.coli	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>	20 <i>3.20</i>	5 <i>0.80</i>	9 <i>1.50</i>	88 <i>1.10</i>	50 <i>0.60</i>	60 <i>0.80</i>	62 <i>1.20</i>	32 <i>0.60</i>	53 <i>1.00</i>
Hepatitis A	2 <i>1.30</i>	2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>	4 <i>0.60</i>	5 <i>0.80</i>	3 <i>0.50</i>	68 <i>0.80</i>	72 <i>0.90</i>	89 <i>1.10</i>	42 <i>0.80</i>	37 <i>0.70</i>	65 <i>1.20</i>
Listerien	1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>		7 <i>1.10</i>	3 <i>0.50</i>	3 <i>0.50</i>	46 <i>0.60</i>	37 <i>0.50</i>	65 <i>0.80</i>	36 <i>0.70</i>	28 <i>0.50</i>	40 <i>0.70</i>

Übertragbare Krankheiten

	Woche 35			Letzte 4 Wochen			Letzte 52 Wochen			Seit Jahresbeginn		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Durch Blut oder sexuell übertragen												
Hepatitis B akut			1 0.60	1 0.20	5 0.80	6 1.00	60 0.80	75 0.90	71 0.90	38 0.70	50 0.90	47 0.90
Total Meldungen (B)	19	22	34	95	76	97	1483	1352	1222	974	917	821
Hepatitis C akut			2 1.30	2 0.30	2 0.30	3 0.50	51 0.60	59 0.70	54 0.70	29 0.50	37 0.70	41 0.80
Total Meldungen (C)	34	38	21	136	101	60	1816	1627	1297	1213	1143	846
Chlamydia trachomatis	205 133.40	164 106.70	151 98.30	688 111.90	621 101.00	571 92.90	8371 104.80	7896 98.80	7039 88.10	5615 104.40	5470 101.70	4847 90.10
Gonorrhoe	31 20.20	41 26.70	28 18.20	128 20.80	143 23.30	118 19.20	1750 21.90	1532 19.20	1266 15.80	1196 22.20	1015 18.90	910 16.90
Syphilis	8 5.20	20 13.00	19 12.40	67 10.90	88 14.30	69 11.20	1133 14.20	1070 13.40	1015 12.70	765 14.20	728 13.50	682 12.70
Zoonosen und andere durch Vektoren übertragbare Krankheiten												
Zeckenenzephalitis	11 7.20	1 0.60	7 4.60	36 5.90	10 1.60	28 4.60	178 2.20	103 1.30	165 2.10	152 2.80	69 1.30	141 2.60
Malaria	7 4.60	6 3.90	11 7.20	23 3.70	23 3.70	27 4.40	208 2.60	174 2.20	213 2.70	138 2.60	110 2.00	139 2.60
Chikungunya-Fieber				1 0.20			4 0.05	2 0.03	4 0.05	3 0.06		4 0.07
Dengue-Fieber	3 2.00			21 3.40	11 1.80	1 0.20	151 1.90	57 0.70	54 0.70	101 1.90	45 0.80	26 0.50
Hantavirus-Infektionen							5 0.06	3 0.04			3 0.06	
Gelbfieber												
Brucellen				1 0.20			5 0.06	5 0.06	8 0.10	4 0.07	3 0.06	6 0.10
Trichinella spiralis							2 0.03			1 0.02		
Tularämie				2 0.30	5 0.80	2 0.30	34 0.40	31 0.40	11 0.10	16 0.30	23 0.40	6 0.10
Q-Fieber ^e	1 0.60			2 0.30			22 0.30			16 0.30		
Andere Meldungen												
Botulismus												
Tetanus						1 0.20			1 0.01			1 0.02
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit ^f										4		

Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Abteilung Übertragbare Krankheiten
Telefon 031 323 87 06

Übertragbare Krankheiten

Sentinella-Statistik

Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis 30.8.2013 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/10³)

Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)

Woche	32		33		34		35		Mittel 4 Wochen	
Thema	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³	N	N/10 ³
Influenza	4	0.5	1	0.1	1	0.1	3	0.3	2.3	0.3
Mumps	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1	0.5	0.1
Otitis Media	8	1.0	23	2.2	29	2.4	19	1.8	19.8	1.8
Pneumonie	2	0.2	3	0.3	9	0.7	5	0.5	4.8	0.4
Pertussis	6	0.7	3	0.3	1	0.1	6	0.6	4	0.4
Meldende Ärzte	91		120		138		123		118	

Provisorische Daten

Übertragbare Krankheiten

Invasive *H. influenzae* Erkrankungen 1988–2011

Seit Empfehlung der Basisimpfung gegen *Haemophilus influenzae* Typ b (Hib) für Kinder im Alter unter 5 Jahren im Jahr 1991 sank die Zahl und Inzidenz der invasiven *H. influenzae* Erkrankungen (IHE) in der Schweiz deutlich. Diese Entwicklung spiegelt sich jedoch nicht in allen Altersgruppen wider. Während die Inzidenz bei den Kindern sank, insbesondere bei den unter 5-Jährigen (von 40 Fällen pro 100 000 Einwohner in der Periode 1988–1990 auf 1 Fall pro 100 000 Einwohner im 2011), stieg sie bei den über 64-Jährigen an (von 1 Fall auf 5 Fälle pro 100 000 Einwohner in den gleichen Zeitperioden).

ÜBERWACHUNG UND IMPFUNG

Meldepflicht

Die invasive *Haemophilus influenzae* Erkrankung (IHE) und die Epiglottitis sind in der Schweiz seit Ende 1987 für Ärzte und Laboratorien meldepflichtig. Seit 2011 entfällt die Pflicht der ärztlichen Erstmeldung von Epiglottitis.

Falldefinition

Die Falldefinition der IHE wurde im 2011 an die Falldefinition des European Centre for Prevention and Disease Control (ECDC) angepasst. In den Jahren 1987–2010 wurden Erkrankungen mit kulturellem Nachweis von *H. influenzae* in normalerweise sterilem Material als sichere Fälle und Epiglottitis (unabhängig vom Labornachweis) als wahrscheinliche Fälle berücksichtigt.

Seit 2011 werden Erkrankungen mit kulturellem Nachweis bzw. neu auch Genomnachweis von *H. influenzae* aus normalerweise sterilem Material als sichere Fälle eingeschlossen.

Impfempfehlung

Seit 1991 wird die Impfung gegen *Haemophilus influenzae* Typ b (Hib) als Basisimpfung empfohlen und durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung vergütet. Die Impfung erfolgt im ersten Lebensjahr und besteht aus drei Dosen im Alter von 2, 4 und 6 Monaten sowie einer Dosis zur Auffrischung im Alter von 15–24 Monaten. Nachholimpfungen sind für unter 5-Jährige angezeigt.

Zurzeit gibt es noch keine Impfungen gegen die übrigen *H. influenzae* Typen a und c–f oder gegen nicht-kapsulierte *H. influenzae*.

ANZAHL FÄLLE UND INZIDENZEN

Seit 1988 wurden dem Bundesamt für Gesundheit insgesamt 1896 Fälle von IHE gemeldet. Von diesen wurden in der Auswertung die 1865 Fälle mit Wohnsitz in der Schweiz oder unbekanntem Wohnsitz berücksichtigt – die 31 Fälle (2 %) mit Wohnsitz im Ausland wurden ausgeschlossen.

Die Zahl der gemeldeten IHE lag in der Periode 1988–1990 vor Empfehlung der Hib-Basisimpfung bei durchschnittlich 190 Fällen pro Jahr. Sie nahm anschliessend rasch auf durchschnittlich je 60 Fälle

in den Perioden 1991–2000 sowie 2001–2010 ab. Im 2011 wurde eine im Vergleich zu den Vorjahren hohe Zahl von 95 Fällen verzeichnet (Tabelle 1, Abbildung 1). Diese Zunahme ist nicht durch die 2011 angepasste Falldefinition bedingt – nur ein Fall wurde ausschliesslich mittels Genomnachweis, der vor 2011 nicht als Nachweis anerkannt wurde, bestätigt.

Die Inzidenz sank entsprechend von im Durchschnitt 2,9 Fällen in der Periode 1988–1990 auf 0,9 und 0,8 Fälle pro 100 000 Einwohner in den beiden nachfolgenden Zehnjahresperioden. Sie lag im 2011 mit 1,2 Fällen pro 100 000 Einwohner etwas höher.

Diese deutliche Abnahme der Fallzahlen und Inzidenzen nach Empfehlung der Hib-Impfung zeigt sich jedoch nicht in allen Altersgruppen, sondern nur bei den Kindern, insbesondere bei den unter 5-Jährigen: In den Perioden 1988–1990, 1991–2000 und 2001–2010 sank bei den unter 1-Jährigen die Inzidenz von durchschnittlich 50,1 auf 10,5 bzw. 4,7 Fälle pro 100 000 Einwohner, bei den 1- bis 4-Jährigen von 37,2 auf 5,3 und 1,4 Fälle pro 100 000 Einwohner. Entgegen diesem Trend wurde bei den über 64-Jährigen in denselben Zeitperioden eine Zunahme von 1,0 auf 1,1 bzw. 2,2 Fälle pro 100 000 Einwohner beobachtet.

Das mittlere Alter der Fälle stieg infolgedessen von 9 auf 28 bzw. 54 Jahre. Damit betrifft die gemeldete IHE nicht mehr überwiegend Kinder – wie vor Einführung der

Tabelle 1

Altersspezifische Fallzahlen und Inzidenzen invasiver *H. influenzae* Erkrankungen
Durchschnittliche jährliche Anzahl und Inzidenz invasiver *H. influenzae* Erkrankungen pro 100 000 Einwohner nach Altersgruppe (Stand der Wohnbevölkerung am 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres); Analyse der Fälle vor und nach Empfehlung der Basisimpfung (1991)

Alter	Ø 1988–1990		Ø 1991–2000		Ø 2001–2010		2011	
	Fälle	Inzidenz	Fälle	Inzidenz	Fälle	Inzidenz	Fälle	Inzidenz
0 Jahre	39,3	50,1	8,7	10,5	3,5	4,7	2,0	2,5
1–4 Jahre	111,7	37,2	17,3	5,3	4,2	1,4	2,0	0,6
5–14 Jahre	17,0	2,3	6,3	0,8	3,0	0,4	4,0	0,5
15–64 Jahre	12,0	0,3	15,3	0,3	22,9	0,4	24,0	0,4
≥65 Jahre	10,0	1,0	11,8	1,1	26,8	2,2	63,0	4,7
Unbekannt	0,0	–	0,2	–	0,0	–	0,0	–
Total pro Jahr	190,0	2,9	59,6	0,9	60,4	0,8	95,0	1,2

Abbildung 1

Altersspezifische Fallzahlen und Inzidenzen der invasiven *H. influenzae* Erkrankungen

Jährliche Fallzahlen und Inzidenzen der invasiven *H. influenzae* Erkrankungen pro 100 000 Einwohner nach Altersgruppe (Stand der Wohnbevölkerung am 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres)

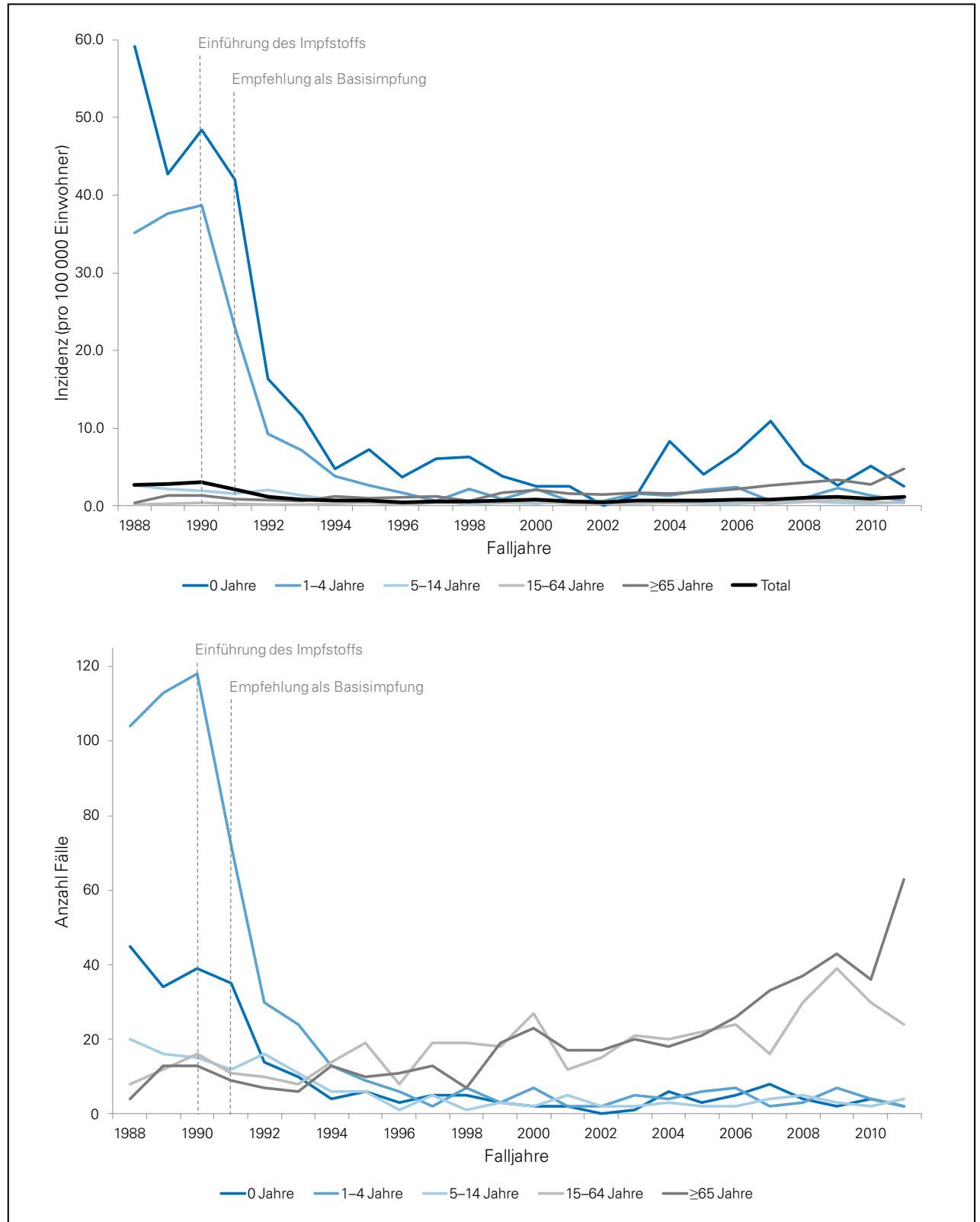


Tabelle 2

Altersspezifische Anzahl Todesfälle und Letalität invasiver *H. influenzae* Erkrankungen

Durchschnittliche jährliche Anzahl Todesfälle und Letalität invasiver *H. influenzae* Erkrankungen nach Altersgruppe; Analyse der Fälle vor und nach Einführung der Hib-Basisimpfung (1991)

Alter	Ø 1988–1990		Ø 1991–2000		Ø 2001–2010		2011	
	Todesfälle	Letalität	Todesfälle	Letalität	Todesfälle	Letalität	Todesfälle	Letalität
0 Jahre	1,0	3 %	0,3	3 %	0,3	9 %	0	0 %
1–4 Jahre	1,3	1 %	0,4	2 %	0,4	10 %	0	0 %
5–14 Jahre	0	0 %	0,1	2 %	0,1	3 %	0	0 %
15–64 Jahre	0,7	6 %	1,1	7 %	1,4	6 %	4	17 %
≥65 Jahre	2,3	23 %	2,3	19 %	4,3	16 %	12	19 %
Unbekannt	0	–	0	0 %	0	–	0	–
Total pro Jahr	5,3	3 %	4,2	7 %	6,5	11 %	16	17 %

Hib-Impfung – sondern mehrheitlich die Erwachsenen, insbesondere die über 64-Jährigen (Tabelle 1, Abbildung 1).

Die geschlechtsspezifischen Inzidenzen zeigten, dass sowohl vor als auch nach Einführung der Impfung Männer insgesamt häufiger von IHE betroffen waren als Frauen. 1988–2011 war das IHE-Risiko der Männer durchschnittlich 1,3 mal höher – je nach Altersgruppe 0,9–1,6 mal höher – als das der Frauen.

LETALITÄT

Vor Einführung der Impfung verliefen jährlich durchschnittlich 5,3 IHE tödlich (Tabelle 2). Nachfolgend blieb die Zahl der Todesfälle in etwa konstant, mit durchschnittlich 4,2 registrierten Todesfällen in der Periode 1991–2000 und 6,5 Todesfällen in der Periode 2001–2010. Die Letalität stieg hingegen während diesen Zeitperioden von 3 % auf 7 % bzw. 11 %.

Je nach Altersgruppe zeigten sich bezüglich der Anzahl letal verlaufener IHE und der Letalität unterschiedliche Tendenzen. Obwohl bei unter 5-jährigen Kindern die Zahl der Todesfälle sank und seit 2007 keine mehr verzeichnet wurden, stieg in diesen Altersgruppen die Letalität tendenziell an, nämlich von durchschnittlich 2 % in der Periode 1988–1990 auf 3 % in der Periode 1991–2000 und 9 % in der Periode 2001–2010. Demgegenüber stieg bei den Erwachsenen in diesen Zeitperioden die Zahl der Todesfälle leicht an, die Letalität veränderte

sich hingegen kaum. Das mittlere Alter der Fälle mit letalem Verlauf stieg entsprechend von 16 Jahren in der Periode 1988–1990 auf 42 bzw. 65 Jahre in den beiden nachfolgenden Zehnjahresperioden.

Die geschlechtsspezifischen Letalitäten der Männer und Frauen unterschieden sich kaum.

KLINIK

In den Jahren nach Einführung der Hib-Basisimpfung veränderte sich die relative Häufigkeit der verschiedenen Krankheitsbilder der IHE, wobei Pneumonien häufiger, Epiglottitiden und Meningitiden hingegen seltener auftraten: In der Periode 1988–1990 manifestierte sich die IHE bei nur 6 % der 529 Fälle mit bekannter Klinik als Pneumonie, in der Periode 1991–2000 hingegen bei 28 % der 541 Fälle bzw. in der Periode 2001–2010 bei 53 % der 535 Fälle. In den gleichen Zeitperioden nahmen Epiglottitiden von 34 % auf 26 % bzw. 7 % sowie die Meningitiden von 52 % auf 34 % bzw. 15 % ab.

Diese Verschiebungen zeigten sich bei allen Altersgruppen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass. Sie sind somit nicht alleinig bedingt durch die Entwicklung der IHE, die hauptsächlich unter 5-jährige Kinder betraf, zu einer Erkrankung, die aktuell mehrheitlich über 64-jährige Erwachsene trifft. Bei unter 5-Jährigen sank vor allem die absolute und relative Häufigkeit der Epiglottitis von 33 % in der Periode 1988–1990 auf 23 % bzw. 9 % in

den beiden nachfolgenden Zehnjahresperioden. Die Zahl der Meningitiden nahm in dieser Altersgruppe ebenfalls ab, wobei jedoch der Anteil der Fälle mit Meningitis mit rund 50 % in etwa konstant blieb. Bei den über 64-Jährigen veränderte sich die Zahl der Epiglottitiden und Meningitiden kaum; die relativen Häufigkeiten sanken jedoch aufgrund der gestiegenen Fallzahlen: Epiglottitiden nahmen von 22 % in der Periode 1988–1990 bzw. 19 % in der Periode 1991–2000 auf 1 % in der Periode 2001–2010 ab, und Meningitiden nahmen in denselben Zeitperioden von 7 % auf 17 % zu und anschliessend auf 5 % ab. In dieser Altersgruppe nahm in den gleichen Zeitperioden vor allem die Anzahl, aber auch der Anteil der Fälle mit Pneumonie zu, nämlich von 63 % auf 64 % bzw. 77 % (Tabelle 3).

Die IHE verlief bei 14 % der Fälle mit Pneumonie letal. Bei vorliegender Epiglottitis oder Meningitis lag die Letalität bei 4 %. Die manifestationsspezifischen Letalitäten unterschieden sich nach Altersgruppe: Bei den unter 5-Jährigen war die Letalität bei Pneumonie 0 % und bei Epiglottitis oder Meningitis 2 %; bei den über 64-Jährigen dagegen verliefen 18 %, 16 % bzw. 15 % der IHE letal.

In allen drei Zeitperioden manifestierte sich die IHE bei den unter 5-jährigen Kindern am häufigsten als Meningitis, bei den über 64-Jährigen hingegen als Pneumonie (Tabelle 3). Bei den 5- bis 14-Jährigen und den 15- bis 64-Jährigen traten

Tabelle 3

Manifestation der invasiven *H. influenzae* Erkrankungen

Manifestation der invasiven *H. influenzae* Erkrankungen bei Fällen mit bekannter Klinik in den Altersgruppen der unter 5-Jährigen sowie der über 64-Jährigen (Mehrfachantworten pro Fall möglich); Analyse der Fälle vor und nach Einführung der Hib-Basisimpfung (1991)

Manifestation	1988–1990	1991–2000	2001–2010	2011
<i><5 Jahre</i>				
Anzahl mit bekannter Klinik	421	244	66	4
(Ø Anzahl pro Jahr)	(140)	(24)	(7)	(4)
Anteil mit bekannter Klinik	93 %	94 %	86 %	100 %
Epiglottitis	33 %	23 %	9 %	0 %
Meningitis	58 %	53 %	53 %	25 %
Pneumonie	1 %	6 %	11 %	0 %
Zellulitis	3 %	6 %	6 %	0 %
Arthritis	1 %	5 %	8 %	0 %
Andere Manifestationen	5 %	8 %	32 %	100 %
<i>≥65 Jahre</i>				
Anzahl mit bekannter Klinik	27	102	239	59
(Ø Anzahl pro Jahr)	(9)	(10)	(24)	(59)
Anteil mit bekannter Klinik	90 %	86 %	89 %	94 %
Epiglottitis	22 %	19 %	1 %	5 %
Meningitis	7 %	17 %	5 %	2 %
Pneumonie	63 %	64 %	77 %	76 %
Zellulitis	0 %	1 %	0 %	2 %
Arthritis	4 %	3 %	1 %	0 %
Andere Manifestationen	93 %	75 %	22 %	27 %

in der Periode 1988–1990 am häufigsten Meningitiden bzw. Epiglottitiden auf, in der Periode 2001–2010 hingegen vor allem Pneumonien.

SEROTYPENVERTEILUNG

Der Anteil der Fälle, bei welchen die Laboratorien den nachgewiesenen Serotypen (a–f, nichtkapsuliert) gemeldet haben, sank von 40 % in der Periode 1988–1990 auf 8 % in der Periode 2001–2010. Die unvollständige Datenlage erlaubt keine zuverlässigen Aussagen zur Serotypenverteilung in der Schweiz. Die Serotypenverteilung dürfte jedoch mit der anderer europäischer Länder – mit ähnlicher Durchimpfung und Altersverteilung der IHE-Fälle – vergleichbar sein: Im UK sank der Anteil der IHE (alle Altersgruppen), die durch Hib verursacht wurden, von 93 % in den Jahren 1990–1992 vor Einführung der Hib-Impfung auf durchschnittlich 33 % in der Periode 1993–2000 bzw. 34 % in der Periode 2001–2008. Demgegenüber stieg in den gleichen Zeitperioden

der Anteil der IHE, die durch nichttypisierbare (nichtkapsulierte) *H. influenzae* bedingt waren, von 6 % auf durchschnittlich 59 % bzw. 57 % [1]. In Deutschland zeigte sich, dass 2011 in 78 % der analysierten Fälle nichttypisierbare (nichtkapsulierte) *H. influenzae*, in 16 % *H. influenzae* Serotyp f, in je 3 % die Serotypen b und e und in unter 1 % Serotyp a für die IHE (alle Altersgruppen) verantwortlich war [2]. Der Anteil der nichtkapsulierten *H. influenzae* war in der Altersgruppe der über 64-Jährigen am höchsten.

IMPFFSTATUS

Der Impfstatus wird seit 1993 mit der Arztmeldung erhoben und ist bei rund 80 % der unter 5-jährigen Fälle bekannt. In dieser Altersgruppe hat sich der Anteil der Fälle, die bei Erkrankung mit mindestens einer Dosis geimpft waren, von 1993–2000 gegenüber 2001–2010 kaum verändert: In der ersten Zeitperiode waren 45 % der 89 Fälle mit bekanntem Impfstatus (gemäss

Anamnese oder Impfausweis) gegen durch Hib verursachte Erkrankungen geimpft, in der zweiten Zeitperiode 50 % der 58 Fälle. Bei den unter 2-Jährigen waren es entsprechend in diesen Zeitperioden 44 % der 50 Fälle bzw. 45 % der 38 Fälle mit bekanntem Impfstatus. (Der Impfstatus wurde in dieser Altersgruppe bei 45 % bzw. 94 % anhand des Impfausweises erhoben.)

Da die Hib-Durchimpfung mit 3 Dosen bei 2-jährigen Kindern seit 1993 auf über 90 % gestiegen ist [3], zeigt dieser geringere Anteil geimpfter Fälle, dass geimpfte Kinder bedeutend seltener von IHE betroffen sind als nicht geimpfte. Von den 41 geimpften unter 2-jährigen Kindern, die dennoch an IHE erkrankten, waren 61 % nur mit 1–2 Dosen und 27 % mit 3–4 Dosen geimpft. Bei 12 % war die Anzahl der Impfdosen nicht bekannt. 24 % der geimpften Fälle in dieser Altersgruppe waren unter 6 Monate alt, konnten somit durch eine Impfung noch nicht vollständig geschützt werden. Zu beachten ist, dass die Impfung nur Hib-bedingte IHE und nicht durch andere Serotypen verursachte IHE verhindern kann. Zu den Serotypen der trotz vollständiger Impfung erkrankten unter 2-jährigen Kinder liegen keine aussagekräftigen Informationen vor.

KOMMENTAR

In den vergangenen 24 Jahren hat sich die IHE von einer «Kinderkrankheit» zu einer Krankheit entwickelt, die hauptsächlich Erwachsene betrifft.

In der Altersgruppe der unter 5-Jährigen hat die Anzahl und Inzidenz der IHE nach Einführung der Hib-Impfung im 1991 stark abgenommen. Die Durchimpfung mit 3 Dosen (bzw. 4 Dosen) im Alter von 2 Jahren betrug in der Periode 1999–2003 rund 91 % (bzw. 79 %), in der Periode 2008–2010 rund 95 % (bzw. 87 %); dies mit relativ geringen interkantonalen Schwankungen [3,4]. Obwohl die Serotypenverteilung der IHE nicht bekannt ist, spricht die stark gesunkene Inzidenz bei zeitgleichem Anstieg der Durchimpfung für den guten Impfschutz der Hib-Impfung. Auch in Europa gibt es nach Einführung der Hib-Impfung keine Hinweise auf ein vermehrtes

Auftreten der anderen Serotypen [5]. In Kanada wurde hingegen bei den unter 5-jährigen Kindern ein gewisses Replacement der Hib durch nichtkapsulierte *H. influenzae* und durch *H. influenzae* f beobachtet [6].

Informationen zu Resistenzen der nachgewiesenen invasiven *H. influenzae* gegenüber Antibiotika werden in der Schweiz nicht im Rahmen der Meldepflicht erhoben. Gemäss den Daten des Schweizerischen Zentrums für Antibiotikaresistenzen (Anresis) [7] waren 2011 insgesamt 16 % der untersuchten *H. influenzae*-Proben von hospitalisierten Patienten resistent gegenüber Aminopenicillinen (Ampicillin, Amoxicillin) und 6 % gegenüber der Kombination Amoxicillin-Clavulansäure. Zudem waren 37 % intermediär bzw. 16 % resistent gegenüber dem Makrolid Clarithromycin, aber nur 1,5 % intermediär bzw. 0,3 % resistent gegenüber dem Makrolid Azithromycin. Resistenzen gegenüber Cephalosporinen der 3. Generation (u. a. Cefixim) traten mit 0,4 % sehr selten und Resistenzen gegenüber neueren Fluorochinolonen (u. a. Levofloxacin und Moxifloxacin) traten keine auf. In Europa wurde zwischen 1997 und 2005 insgesamt eine Abnahme der Amoxicillinresistenz (von 20 % auf 16 %), keine Resistenzen gegenüber Cefixim, Levofloxacin bzw. Moxifloxacin und nur sehr selten (<0,5 %) Resistenzen gegenüber Amoxicillin-Clavulansäure und Azithromycin beobachtet [8].

Die Letalität nimmt tendenziell zu, insbesondere bei den unter 5-jährigen Kindern. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass der Anteil der IHE, die durch Hib verursacht wurden, gesunken ist. In der Altersgruppe der unter 5-Jährigen war gemäss Beobachtungen in anderen europäischen Ländern die Letalität der «nicht Serotyp b» und insbesondere der nichtkapsulierten *H. influenzae* bedeutend höher als die der Hib [9]. Entsprechend wurde auch in den USA für Erwachsene und unter 1-jährige Kinder gezeigt, dass die Letalität einer IHE bei Infektion mit nichtkapsulierten *H. influenzae* höher war als bei Infektion mit kapsulierten *H. influenzae* [10].

Bemerkenswert ist die seit Beginn der Überwachung zu beobachtende Zunahme der IHE-Inzidenz bei den über 64-Jährigen. In den USA

[11] und in einigen Ländern Europas (z. B. in Frankreich [12]), die Hib-Impfprogramme bei Kindern durchführen und eine ähnlich hohe Durchimpfung wie die Schweiz erreicht haben, wurde gleiches beobachtet. Für die Zunahme der IHE waren hauptsächlich nichtkapsulierte *H. influenzae* verantwortlich [11–12].

Vor diesem Hintergrund ist die fortgesetzte Überwachung der IHE in der Schweiz notwendig, um die Veränderungen der IHE-Epidemiologie bzw. die Langzeitwirkung der Hib-Impfung verfolgen und gegebenenfalls die Impfempfehlung anpassen zu können.

Das Bundesamt für Gesundheit dankt allen meldenden Ärztinnen/Ärzten und Laboratorien für ihren Einsatz in der Prävention, Behandlung und Überwachung dieser Erkrankung. ■

Kontakt

Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Abteilung Übertragbare Krankheiten
Telefon 031 323 87 06

Referenzen

1. Health Protection Agency HPA im UK. Laboratory reports of *Haemophilus influenzae* infection by serotype and year: England and Wales, 1990 to 2010, zugegriffen am 27.12.2012, www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/HaemophilusInfluenzaeTypeB/EpidemiologicalData/haem_DataAllSerotypes/
2. Konsiliarlabor für *Haemophilus influenzae* in Deutschland. Daten des Konsiliarlabors für *Haemophilus influenzae* 2011, zugegriffen am 27.12.2012, www.haemophilus.uni-wuerzburg.de/startseite/berichte/daten_2011/
3. Bundesamt für Gesundheit. Durchimpfung von 2-, 8- und 16-jährigen Kindern in 15 Kantonen der Schweiz, 2008–2010, BAG Bulletin 2012; 40: 681–686.
4. Lang P, Zimmermann H.P, Piller U, Steffen R, Hatz C. The Swiss National Vaccination Coverage Survey 2005–2007. Public Health Rep. 2011; 126(Suppl 2): 97–108.
5. Ladhani S, Ramsay M.E, Chandra M, Slack M.P. EU-IBIS. No evidence for *Haemophilus influenzae* serotype replacement in Europe after introduction of the Hib conjugate vaccine, Lancet 2008; 8(5): 275–276.
6. Adam H.J, Richardson S.E, Jamieson F.B, Rawte P, Low D.E, Fisman D.N. Changing epidemiology of invasive *Haemophilus influenzae* in Ontario, Canada: Evidence for herd effects and strain replacement due to Hib vaccination. Vaccine 2010; 28: 4073–4078.
7. Schweizerisches Zentrum für Antibiotikaresistenzen (anresis.ch) Resistenzdaten Humanmedizin für *Haemophilus influenzae* 2010 und 2011, zugegriffen am 18.03.2013, [www.search.ifik.unibe.ch/de/index.html#javascript:loadContent\('#content-data','include/resistancedataselection.html'\)](http://www.search.ifik.unibe.ch/de/index.html#javascript:loadContent('#content-data','include/resistancedataselection.html'))
8. Jansen W.T, Verel A, Beitsma M, Verhoef J, Milatovic D. Longitudinal European surveillance study of antibiotic resistance of *Haemophilus influenzae*. J Antimicrob. Chemother. 2006; 58(4): 873–877.
9. European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC. Surveillance of invasive bacterial diseases in Europe 2008/2009. Stockholm: 2011.
10. Livorsi D, MacNeil J.R, Cohn A.C, Bareta J, Zansky S, Petit S, Gershman K, Harrison L.H, Lynfield R, Reingold A, Schaffner W, Thomas A, Farley M.M. Invasive *Haemophilus influenzae* in the United States, 1999–2008: Epidemiology and outcomes. J Infect. 2012; 65(6): 496–504.
11. Rubach M.P, Bender J.M, Mottice S, Hanson K, Wenig H.Y.C, Korgenski K, Daly J.A, Pavia A.T. Increasing incidence of invasive *Haemophilus influenzae* disease in adults, Utah, USA. Emerg. Infect. Dis. 2011; 17(9): 1645–1650.
12. Georges S, Lepoutre A, Dabernat H, Levy-Bruhl D. Impact of *Haemophilus influenzae* type b vaccination on the incidence of invasive *Haemophilus influenzae* disease in France, 15 years after its introduction. Epidemiol. Infect. 2013; 141(9): 1787–1796.

Informationsschreiben Nr. 171: Empfehlung zur Beurteilung von Perchloratrückständen in Lebensmitteln

Sehr geehrte Damen und Herren

In den letzten Monaten wurde das Bundesamt für Gesundheit BAG darauf aufmerksam gemacht, dass vermehrt erhöhte Rückstände von Perchlorat in Früchten und Gemüse nachgewiesen wurden. Perchlorate sind Salze der Perchlorsäure, die sowohl natürlich im Boden und in der Atmosphäre vorkommen als auch industriell hergestellt und eingesetzt werden können. Dadurch können Perchlorate als Rückstände in Lebensmittel gelangen. Der Nachweis erhöhter Rückstände deutet jedoch darauf hin, dass eine ungewöhnliche Kontaminationsquelle besteht, die ergründet werden muss.

Untersuchungen, die in der Schweiz und im benachbarten Ausland durchgeführt wurden, konnten bisher die Ursache erhöhter Rückstände nicht eindeutig klären. Da Perchlorat als Arzneimittel zur Behandlung von Schilddrüsenüberfunktionen verwendet wird, muss sichergestellt werden, dass mögliche Rückstände kein gesundheitliches Risiko darstellen. Aus diesem Grund besteht das Bedürfnis, die betroffenen Produkte, insbesondere Früchte und Gemüse, lebensmittelrechtlich beurteilen zu können.

Das Schweizer Lebensmittelrecht enthält aktuell keine Höchstkonzentrationen für Perchlorat in Früchten und Gemüse. Daher gilt der allgemeine Grundsatz, dass nur technisch unvermeidbare und gesundheitlich unbedenkliche Mengen von Fremdstoffen in Lebensmitteln verbleiben dürfen (Art. 10 Abs. 1 LMG, Art. 8 LGV, Art. 1 FIV).

Zur gesundheitlichen Bewertung von Perchlorat stützt sich das BAG, wie das zuständige Expertengremium der EU (Ständiger Ausschuss über die Lebensmittelkette und die Tiergesundheit (SCoFCAH)), insbesondere auf eine Beurteilung des internationalen Gremiums der JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives). Bis Ende Jahr ist eine Beurteilung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) vorgesehen, die die EU-Kommission in Auftrag gegeben hat.

Beim Nachweis von Perchlorat in Konzentrationen über den unten aufgeführten Werten für Perchlorat empfiehlt das BAG, unter Berücksichtigung der durch das SCoFCAH am 16. Juli 2013 beschlossenen provisorischen Höchstwerte, aus Gründen des Gesundheitsschutzes und des Täu-

schungsschutzes die betroffenen Lebensmittel zu beanstanden.

Die Werte beziehen sich auf die verzehrbaren Anteile des Lebensmittels.

Das BAG empfiehlt allen Beteiligten, die Ursachen der Kontamination zu ergründen, damit Rückstände von Perchlorat möglichst gering gehalten werden können. Insbesondere sollen Produktionsmittel wie Dünger, Wasser und Substrat als Kontaminationsquelle für Perchlorat untersucht werden. Sobald zusätzliche Informationen zur gesundheitlichen Bewertung von Perchloraten, über die möglichen Kontaminationsquellen und neue Untersuchungsergebnisse vorliegen, wird das BAG die provisorischen Höchstwerte überprüfen. ■

Kontakt

Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz
Abteilung Lebensmittelsicherheit
Telefon 031 322 05 05

1	2	3	4
Stoff	Lebensmittel	Wert mg/kg	Bemerkungen
Perchlorat	Blattgemüse	1	ausgenommen Spinat; aus gedeckten Kulturen
"	frische Kräuter	1	aus gedeckten Kulturen
"	Stangensellerie	1	aus gedeckten Kulturen
"	Gemüse	0.5	übriges
"	Obst	0.5	übriges
"	Kernobst	0.2	
"	Melonen	0.2	
"	Spinat	0.2	
"	Tafeltrauben	0.2	
"	Wassermelonen	0.2	
"	Wurzel- und Knollengemüse	0.2	
"	Zitrusfrüchte	0.2	

Kranken- und Unfallversicherung

Spezialitätenliste

Die Spezialitätenliste ist im Internet zu finden unter: www.sl.bag.admin.ch

Pharmacode

Der Pharmacode ist ein Identifikationscode der Firma e-mediat, der von den Zulassungsinhaberinnen bei der Firma e-mediat beantragt werden muss und für die Zulassungsinhaberinnen kostenpflichtig ist. Da der Code von einem privaten Unternehmen gegen Gebühr und nicht vom BAG vergeben wird und nicht alle Arzneimittel auf der Spezialitätenliste (SL) einen Pharmacode aufweisen, wird das BAG ab 1. Januar 2015 auf eine Publikation des Pharmacodes in der SL verzichten. Für Fragen und Rückmeldungen zu den oben genannten Anpassungen kontaktieren Sie das BAG unter eak-sl-sekretariat@bag.admin.ch.

Gültig ab 1. August 2013

{ } Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis

Neu gestrichene Präparate/Packungen

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme-jahr
01.99.00 (L)	17960	Ebixa (Memantin hydrochloridum) Filmtabl 10 mg 50 Stk Fr. 119.65 {89.96}	Lundbeck (Schweiz) AG	55828007	01.08.2013, B
(L)	17960	Ebixa Starterpack (Memantin hydrochloridum) Filmtabl 7x5, 7x10, 7x15, 7x20 mg 28 Stk Fr. 81.75 {56.92}	Lundbeck (Schweiz) AG	55828015	01.08.2013, B

Diese wurden durch die laktosefreie Form ersetzt.

Gültig ab 1. September 2013

{ } Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis

I. Neuzugang Präparate

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme-jahr
01.05.00	20064	Latuda (Lurasidoni hydrochloridum) Filmtabl 40 mg 28 Stk Fr. 187.40 {148.96}	Takeda Pharma AG	62785001	01.09.2013, B
	20064	Filmtabl 40 mg 56 Stk Fr. 317.35 {262.17}		62785002	01.09.2013, B
	20064	Latuda (Lurasidoni hydrochloridum) Filmtabl 80 mg 28 Stk Fr. 296.90 {244.34}	Takeda Pharma AG	62785003	01.09.2013, B
	20064	Filmtabl 80 mg 56 Stk Fr. 510.10 {430.04}		62785004	01.09.2013, B
(L)	19890	Sycrest (Asenapinum) Behandlung der akuten mittelschweren und schweren manischen Episode einer Bipolar-I-Störung bei Erwachsenen bis zu 12 Wochen. Subling Tabl 5 mg 60 Stk Fr. 221.45 {178.61}	Lundbeck (Schweiz) AG	62073002	01.09.2013, B
(L)	19890	Sycrest (Asenapinum) Subling Tabl 10 mg 60 Stk Fr. 221.45 {178.61}	Lundbeck (Schweiz) AG	62073004	01.09.2013, B
01.08.00 G	20125	Ropinirol Mepha retard (Ropinirolum) Depotabs 2 mg 28 Stk Fr. 42.70 {22.90}	Mepha Pharma AG	62614002	01.09.2013, B
G	20125	Ropinirol Mepha retard (Ropinirolum) Depotabs 4 mg 28 Stk Fr. 63.10 {40.70}	Mepha Pharma AG	62614003	01.09.2013, B
G	20125	Ropinirol Mepha retard (Ropinirolum) Depotabs 8 mg 28 Stk Fr. 94.00 {67.60}	Mepha Pharma AG	62614004	01.09.2013, B
03.04.30	20035	Seebri Breezhaler (Glycopyrronium) Inh Kaps 50 mcg 30 Stk Fr. 64.15 {41.61}	Novartis Pharma Schweiz AG	62580001	01.09.2013, B
	20035	Inh Kaps 50 mcg 3 x 30 Stk Fr. 159.70 {124.83}		62580002	01.09.2013, B

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme-jahr
05.99.00 G		Tamsulosin T Helvepharm (Tamsulosini hydrochloridum)	Helvepharm AG		
	20126	Ret Tabl 0.400 mg 10 Stk Fr. 15.60 {6.45}		62817001	01.09.2013, B
	20126	Ret Tabl 0.400 mg 30 Stk Fr. 28.05 {13.75}		62817002	01.09.2013, B
	20126	Ret Tabl 0.400 mg 100 Stk Fr. 68.55 {45.43}		62817003	01.09.2013, B
06.01.10 (L)		Willfact (von Willebrand factor)	Opopharma AG		
Preisberechnung für Blutpräparate aufgrund des Fabrikabgabepreises inkl. MWST zuzüglich einer Fixmarge von Fr. 40.– wegen der speziellen Verteilersituation (praktisch kein Zwischenhandel). Diese Berechnung gilt nicht für die Humanalbumine.					
	20069	Trockensub 1000 IE c Solv (10ml) Durchstf 1 Stk Fr. 1'066.20 {1'026.20}		62444001	01.09.2013, B
07.15.00 G		Myfenax (Mofetili mycophenolas)	Teva Pharma AG		
	20123	Kaps 250 mg 100 Stk Fr. 138.55 {106.42}		59220001	01.09.2013, B
	20123	Kaps 250 mg 3 x 100 Stk Fr. 382.90 {319.26}		59220002	01.09.2013, B
G		Myfenax (Mofetili mycophenolas)	Teva Pharma AG		
	20124	Filmtabl 500 mg 50 Stk Fr. 128.25 {97.44}		59221001	01.09.2013, B
	20124	Filmtabl 500 mg 3 x 50 Stk Fr. 351.95 {292.30}		59221003	01.09.2013, B
10.99.00		Picato (Ingenolum mebutatum)	LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.		
	20072	Gel 150 mcg/g 3 Tb 0.470 g Fr. 119.00 {89.38}		62763001	01.09.2013, B
		Picato (Ingenolum mebutatum)	LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.		
	20072	Gel 500 mcg/g 2 Tb 0.470 g Fr. 119.00 {89.38}		62763002	01.09.2013, B
17.03.00		Tekcis Tc-99m (Molybdenum)	CBI Medical Products Vertriebs GmbH		
	20103	Generator 1 Stk Fr. { }		62442001	01.09.2013, A

{ } Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis

II. Andere Packungen und Dosierungen

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme-jahr
07.08.10(L)		Choriomon (Gonadotropinum chorionicum (HCG))	IBSA Institut Biochimique SA Headquarters and Marketing Ope		
Nicht zur Adipositasbehandlung. Kostenübernahme nur nach vorgängiger endokrinologischer Untersuchung, auf besondere Gutsprache der Kasse und mit ausdrücklicher Bewilligung des Vertrauensarztes. Die maximale Behandlungsdauer beträgt ein Jahr.					
	17071	Trockensub 1000 IE c Solv (Spritze) Durchstf 3 Stk Fr. 15.65 {6.47}		33524183	01.09.2013, B
(L)		Choriomon (Gonadotropinum chorionicum (HCG))	IBSA Institut Biochimique SA Headquarters and Marketing Ope		
	17071	Trockensub 2000 IE c Solv (Spritze) Durchstf 3 Stk Fr. 17.60 {8.17}		33524184	01.09.2013, B
(L)		Choriomon (Gonadotropinum chorionicum (HCG))	IBSA Institut Biochimique SA Headquarters and Marketing Ope		
	17071	Trockensub 5000 IE c Solv (Spritze) Durchstf 3 Stk Fr. 34.70 {15.93}		33524186	01.09.2013, B
08.09.00 (L)		Hizentra (Immunoglobulinum humanum normale)	CSL Behring AG		
Nur bei Antikörpermangelsyndrom und idiopathischer thrombozytopenischer Purpura; Kostenübernahme auf besondere Gutsprache der Kasse. Bei ernster Polyradikuloneuropathie (Guillain-Barré-Syndrom), die gegenüber der durch kontrollierte Studien etablierten Behandlung resistent ist.					
	19466	Inj Lös 10 g/50ml Durchstf 50 ml Fr. 730.45 {622.00}		61547013	01.09.2013, B

Gemäss Art. 68 Abs. 2 der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) wird eine Streichung von Medikamenten aus der SL erst drei Monate nach Veröffentlichung im BAG-Bulletin wirksam.

{ } Der dem verfügbaren Publikumspreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis

III. Neu gestrichene Präparate/Packungen

Therap. Gruppe	Dossier-Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme-jahr
01.07.10 O		Lamictal (Lamotriginum)	GlaxoSmithKline AG		
	16046	Disp Tabl 25 mg 21 Stk Fr. 14.00 {5.05}		52853109	01.09.2013, B
	16046	Disp Tabl 25 mg 42 Stk Fr. 25.90 {11.85}		52853087	01.09.2013, B
O		Lamictal (Lamotriginum)	GlaxoSmithKline AG		
	16046	Disp Tabl 50 mg 42 Stk Fr. 44.65 {24.61}		52853095	01.09.2013, B
03.02.00 O		Rhinathiol (Carbocisteinum)	Sanofi-Aventis (Suisse) SA		
	18100	Sirup Erw ohne Zucker Fl 300 ml Fr. 16.35 {8.85}		54112041	01.09.2013, D
05.01.00 G		Oedemex (Furosemidum)	Mepha Pharma AG		
	14685	Inj Lös 20 mg/2ml 5 Amp 2 ml Fr. 5.25 {1.00}		46097017	01.09.2013, B
06.01.10 (L)		Octanine F (Factor IX coagulationis humanus)	Octapharma AG		
	18687	Trockensub 250 IE c Solv Durchstf 1 Stk Fr. 229.70 {189.70}		00659001	01.09.2013, B
(L)		Octanine F (Factor IX coagulationis humanus)	Octapharma AG		
	18687	Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 1 Stk Fr. 419.35 {379.35}		00659002	01.09.2013, B
(L)		Octanine F (Factor IX coagulationis humanus)	Octapharma AG		
	18687	Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 1 Stk Fr. 798.75 {758.75}		00659003	01.09.2013, B
06.03.30		Fraxiforte 0.6 ml (Nadroparinum calcicum)	GlaxoSmithKline AG		
	17064	Inj Lös 6 Fertspr 0.600 ml Fr. 95.30 {68.71}		54499051	01.09.2013, B
		Fraxiforte 0.8 ml (Nadroparinum calcicum)	GlaxoSmithKline AG		
	17064	Inj Lös 6 Fertspr 0.800 ml Fr. 140.40 {108.03}		54499086	01.09.2013, B
		Fraxiforte 1 ml (Nadroparinum calcicum)	GlaxoSmithKline AG		
	17064	Inj Lös 6 Fertspr 1 ml Fr. 176.10 {139.13}		54499108	01.09.2013, B
07.15.00		Simulect (Basiliximabum)	Novartis Pharma Schweiz AG		
	17118	Trockensub 20 mg c solv Amp 1 Stk Fr. 2'310.10 {2'050.24}		54630018	01.09.2013, B
07.16.10 G		Paclitaxel Mepha (Paclitaxelum)	Mepha Pharma AG		
	18302	Inf Konz 30 mg Durchstf 5 ml Fr. 59.45 {37.50}		57350008	01.09.2013, A
G		Paclitaxel Mepha (Paclitaxelum)	Mepha Pharma AG		
	18302	Inf Konz 100 mg Durchstf 16.700 ml Fr. 102.50 {75.00}		57350010	01.09.2013, A
G		Paclitaxel Mepha (Paclitaxelum)	Mepha Pharma AG		
	18302	Inf Konz 300 mg Durchstf 50 ml Fr. 274.70 {225.00}		57350011	01.09.2013, A

IV. Freiwillige Preissenkungen

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Esomep i.v. Trockensub 40 mg Amp 1 Stk	AstraZeneca AG	49900	4703313	19414	8.75	4.07
Lev Desitin Filmtabl 250 mg Minipacks 30 Stk	Desitin Pharma GmbH	10710	4876723	19417	27.80	13.49
Lev Desitin Filmtabl 500 mg Minipacks 20 Stk	Desitin Pharma GmbH	10710	4876769	19417	28.05	13.73
Filmtabl 500 mg Minipacks 100 Stk			4876752	19417	98.15	71.19
Filmtabl 500 mg Minipacks 200 Stk			4876746	19417	175.70	138.76
Lev Desitin Filmtabl 1000 mg Minipacks 30 Stk	Desitin Pharma GmbH	10710	4876798	19417	67.95	44.89
Filmtabl 1000 mg Minipacks 100 Stk			4876781	19417	174.35	137.58
Filmtabl 1000 mg Minipacks 200 Stk			4876775	19417	321.65	265.89

IVa. Preissenkungen nach Patentablauf

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Betoptic S Gtt Opht 5 ml	Alcon Switzerland SA	110900	1695599	16501	15.50	6.37
Gtt Opht 3x 5 ml			1807561	16501	35.05	16.26

V. Preissenkung nach Erweiterung der Limitation

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Victoza Inj Lös 6 mg/ml 2 Fertigpen 3 ml	NOVO NORDISK PHARMA AG	70620	4400162	19173	169.10	133.01

VI. Preiserhöhungen

Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	Therap. Gruppe	Pharma- Code	Dossier- Nr.	Preis neu	Ex-Fact. neu
Nopil Sirup Kind 200/40mg 100 ml	Mepha Pharma AG	80194	776433	12828	6.05	1.68
Nopil forte Tabl 800/160mg (neu) 3 Stk	Mepha Pharma AG	80194	5488911	12654	5.00	0.77
Tabl 800/160mg (neu) 10 Stk			5488928	12654	6.05	1.72
Tabl 800/160mg (neu) 50 Stk			5488934	12654	15.20	6.10

VII. Limitationsänderungen

Therap. Gruppe	Dossier- Nr.	Präparate/Wirkstoffe Packungen	Verantwortliche Firma	SHI-Nr.	Aufnahme- jahr
070620 (L)	19173	Victoza (Liraglutidum) Inj Lös 6 mg/ml 2 Fertigpen 3 ml Fr. 169.10 {133.01}	NOVO NORDISK PHARMA AG	59329001	01.02.2010, B

Limitatio:

Zur Behandlung von Patienten mit einem Typ 2 Diabetes mellitus, in ausschliesslicher Kombinationstherapie mit Metformin, einem Sulfonylharnstoff oder einer Kombination aus Metformin und einem Sulfonylharnstoff oder Metformin und einem Thiazolidindion, wenn durch diese oralen Antidiabetika keine ausreichende Blutzuckerkontrolle erreicht wird.

Limitatio neu:

In Kombination mit Basalinsulin ausschliesslich bei Patienten mit ungenügender Blutzuckerkontrolle unter vorgängiger Therapie mit Metformin und VICTOZA.

Limitatio alt:

Mindestens BMI 28. Zusätzliche Medikamente zur Gewichtsreduktion werden nicht vom Krankenversicherer vergütet.

VIII. Namensänderungen

Alfuzosin Cimex heisst neu FUZOCIM
Gabapentin Teva heisst neu GABAPENTIN MEPHA
Itraconazol Cimex heisst neu ITRACIM
Levodopa/Carbidopa Cimex heisst neu LEVACIN
Lisinopril Spirig heisst neu LISINOPRIL SPIRIG HC
Metformin Teva heisst neu METFORMIN MEPHA
Quetiapin Spirig heisst neu QUETIAPIN SPIRIG HC

Betäubungsmittel

Rezeptsperrung

Folgende Rezepte sind gesperrt

Kanton	Block-Nrn.	Rezept-Nrn.
Aargau	139560D	3488976–3489000

Swissmedic
Abteilung Betäubungsmittel

Love Life

Übertragbare Krankheiten

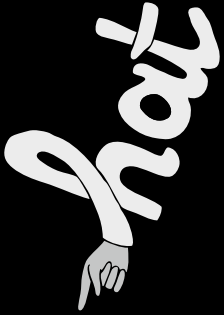


Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

1. Bindungen immer mit Gummi.
2. Sperma und Blut nicht in den Mund.
3. Bei Juckreiz, Brennen oder Ausfluss zum Arzt.



mein DINGES hat Dingabumy





AIDS-HILFE SCHWEIZ
AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA
AIUTO AIDS SVIZZERO

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

SANTÉ SEXUELLE Suisse
SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz
SALUTE SESSUALE Svizzera

**Sprich über
Geschlechts-
krankheiten.
Egal wie.**
.....
Tipps für das Gespräch
mit deinem Partner:
check-your-lovelife.ch

PPA 3003 Bern
PP/Journal
CH-3003 Bern

Adressberechtigungen: BAG Bulletin BBL, Vertrieb Publikationen CH-3003 Bern
--

Bulletin 37/13